



נוהל מס': 018.14
שם הנוהל: טיפול אנטיביוטי מונע בחיתוך דופן
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: 19/11/14
	שם הנוהל: טיפול אנטיביוטי מונע בחיתוך דופן		מהדורה: ראשונה
	כותב הנוהל: ד"ר רויטל לינדר, פרופ' מ.ק. עידו שולט		תאריך עדכון:
	מאשר הנוהל: פרופ' זאב וינר	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופ' אריה דרוגן	נספחים:
מס' דפים: 4	על החתום:	על החתום:	

תוכן העניינים

העמוד

הנושא

2	1. רקע
2	2. מטרות הנוהל
2	3. הגדרות ומונחים
2	4. סמכות ואחריות
2	5. עקרונות הנוהל
3	6. דיווח ותיעוד
3-4	7. ספרות

רקע

מתן טיפול אנטיביוטי מונע סביב ניתוח חיתוך דופן מפחית תחלואה זיהומית בתר-ניתוחית הן בניתוחים לאחר פקיעת קרומים או בלידה פעילה והן בניתוחים אלקטיביים, טרם פקיעת קרומים או תחילת צירים (Smaill et al. 2010, NICE guidelines CG132).

בניתוחים ככלל, מומלץ כי ריכוז האנטיביוטיקה המניעתית בעור יהיה מקסימלי בעת ביצוע החתך הניתוחי. ניתוח חיתוך דופן אינו יוצא דופן מכלל זה (12-1). למרות זאת, מחקרים קודמים מראים ריכוז Cefazolin משמעותי בפלזמת הילוד במידה והטיפול המונע ניתן טרם חיתוך השורר (14-13). ולכן, בחלק מהמרכזים, באופן מסורתי, הטיפול האנטיביוטי המונע ניתן לאחר ניתוק השורר, על מנת שלא להשפיע על צמיחת החיידקים בתרביות הדם מהילודים, וכך 'למסך' תחלואה זיהומית או ברור אלה דם בילוד.

מחקרים רבים (12-1), מראים כי הקדמת מתן הטיפול האנטיביוטי המונע בחיתוך דופן מפחיתה תחלואה זיהומית ביולדות, ללא השפעה משמעותית על הילוד (Lamont et al. 2011).

מטרות הנוהל

הגדרת מועד מתן טיפול אנטיביוטי מונע בחיתוך דופן.

הגדרות ומושגים

טיפול מוקדם - מתן טיפול אנטיביוטי מונע טרם החתך בעור.

טיפול מאוחר - מתן טיפול אנטיביוטי מונע לאחר חיתוך השורר.

סמכות ואחריות

ככלל, האחריות לרישום ההוראה, ביצועה ותעודה על המרדים, הטיפול ינתן בניתוחים אלקטיביים בחדר הניתוח. בניתוחים דחופים, הטיפול ינתן בחדר לידה באחריות צוות המיילדות. במידה ומבוצע ניתוח בהול ולא ניתן הטיפול טרם הניתוח, יש לבקש מהמרדים לתת את הטיפול המונע מוקדם ככל שניתן.

עקרונות הנוהל

בכל חיתוך דופן, למעט ניתוח בהול, יש לתת טיפול מוקדם: מנה חד פעמית של צפמזין 1 גרם תוך ורידי, 30-60 דקות לפני ביצוע החתך בעור, רצוי 30 דקות. במידה וקיימת רגישות לצפלוספורינים, יש לתת קלינדמציין 900 מ"ג תוך ורידי, באותו התזמון. במידה והניתוח מתארך, לאחר 4 שעות יש לתת מנת טיפול מונע נוספת.

נוהל מס': 018.14
שם הנוהל: טיפול אנטיביוטי מונע בחיתוך דופן
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



דיווח ותיעוד

האחריות לרישום ההוראה, ביצועה ותעודה על המרדים. מתן הטיפול יתועד גם בדו"ח הניתוח.

ספרות

1. Smaill FM, Gyte GM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1).
2. National Institute for Health and Clinical Excellence. CG132 Caesarean Section. <http://guidance.nice.org.uk/CG132>. November 2011, Affirmed July 2014.
3. ACOG, Use of prophylactic antibiotics in labor & delivery. Washington (DC): 2011 Jun. (ACOG practice bulletin; no. 120).
4. Lamont RF, Sobel JD, Kusanovic JP, Vaisbuch E, Mazaki-Tovi S, Kim SK, Uldbjerg N, Romero R. Current debate on the use of antibiotic prophylaxis for caesarean section. BJOG. 2011 Jan;118(2):193-201.
5. Witt A, Döner M, Petricevic L, Berger A, Germann P, Heinze G, Tempfer C. Antibiotic prophylaxis before surgery vs after cord clamping in elective cesarean delivery: a double-blind, prospective, randomized, placebo-controlled trial. Arch Surg. 2011 Dec;146(12):1404-9.
6. Brown J, Thompson M, Sinnya S, Jeffery A, de Costa C, Woods C, Howat P, Raulli A. Pre-incision antibiotic prophylaxis reduces the incidence of post-caesarean surgical site infection. J Hosp Infect. 2013 Jan;83(1):68-70.
7. Sun J, Ding M, Liu J, Li Y, Sun X, Liu T, Chen Y, Liu J. Prophylactic administration of cefazolin prior to skin incision versus antibiotics at cord clamping in preventing postcesarean infectious morbidity: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Gynecol Obstet Invest. 2013;75(3):175-8.
8. Baaqeel H, Baaqeel R. Timing of administration of prophylactic antibiotics for caesarean section: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2013 May;120(6):661-9.

נוהל מס': 018.14
שם הנוהל: טיפול אנטיביוטי מונע בחיתוך דופן
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



9. Francis C, Mumford M, Strand ML, Moore ES, Strand EA. Timing of prophylactic antibiotic at cesarean section: a double-blinded, randomized trial. J Perinatol. 2013 Oct;33(10):759-62.
10. Bhattacharjee N, Saha SP, Patra KK, Mitra U, Ghoshroy SC. Optimal timing of prophylactic antibiotic for cesarean delivery: a randomized comparative study. J Obstet Gynaecol Res. 2013 Dec;39(12):1560-8.
11. Heesen M, Klohr Straube S. Concerning the timing of antibiotic administration in women undergoing caesarian section: a systemic review and meta-analysis. BMJ Open 2013; 3:e002028.
12. Lamont RF, Joergensen JS. Prophylactic antibiotics for caesarean section administered preoperatively rather than post cord clamping significantly reduces the rate of endometritis. Evid Based Med. 2014 Feb;19(1):17.
13. Fiore Mitchell T, Pearlman MD, Chapman RL, Bhatt-Mehta V, Faix RG. Maternal and transplacental pharmacokinetics of cefazolin. Obstet Gynecol. 2001 Dec;98(6):1075-9.
14. Creatsas G, Pavlatos M, Lolis D, Kaskarelis D. A study of the kinetics of cephalixin and cephalixin in pregnancy. Curr Med Res Opin. 1980;7(1):43-6.